

Sotsiaaltöö ja sotsiaaltööhäridusega seotud päevakajalised teemad Ühendkuningriigis



Malcolm Payne

emeritiitprofessor, Manchesteri Metropolitani Ülikool tervishoiu-, hoolekande- ja haridusteaduskonna auprofessor, Kingstoni Ülikool / Londoni Ülikooli St George'i kolledž

Ühendkuningriigi hoolekandesüsteem¹

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki koosneb neljast riigist: lisaks Inglismaale, mis on neist suurim, ka Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Wales. Ühendkuningriigi parlament koguneb Londonis Westminsteri palees. Parlament vastutab nii ühiste teemade kui ka üksnes Inglismaad puudutavate poliitikamuudatuste ja seaduste eest, sealhulgas tervishoiu ja hoolekande valdkonnas. Teistes riikides vastutavad tervishoiu ja hoolekandega seotud poliitika ja teenuste eest rahvusparlamendid või -assambleed. Selles artiklis keskendun peamiselt Inglismaale, kus on hästi jälgitavad terves Ühendkuningriigis valitsevad suundumused, ning käsitlen viimase kümne aasta jooksul toimunud vastuolulisi arenguid ja nende tagajärgi.

Sotsiaaltöö staatus ja roll

Ühendkuningriigis on sotsiaaltöö tunnustatud profession, ent nii sotsiaaltöötajate kutsetegevus kui ka hoolekanne satuvad sageli meedia ja poliitiliste rünnakute alla, tihti seoses haavatavate lastele turvalisuse kindlustamise ja hoolduse standarditega institutsionaalses hoolekandes. Need sündmused süvendavad kahtlusi sotsiaalteenuste korralduse ja kutsetegevuse suhtes. Sellised kahtlused annavad omakorda alust poliitiliseks kriitikaks sotsiaaltöö aadressil, mida tehakse parempoolsest vaatenurgast.

Kriitika seab kahtluse alla pigem teenused ja kutsetegevuse, mis tegeleb „sotsiaalsete” küsimustega ja mitte traditsiooniliste avalike teenustega nagu haridus, tervishoid, eluasemeteenused ja sotsiaalkindlustus. Sellega soovitakse muuta riigi roll minimaalseks, et

¹ Hoolekanne, ingl *social care* on organisatsiooni *Social Care Institute for Excellence*, www.scie.org.uk definitsiooni kohaselt sotsiaaltöö-, isikuhooldus-, kaitset või sotsiaalset tuge pakkuvate teenuste osutamine häda- või riskiolukorras olevatele lastele ja täiskasvanutele või haigusest, puudest, vanadusest, aga ka vaesusest tingitud abivajadustega täiskasvanutele. Nimetatud teenuste osutamisel võib olla üks või mitu järgnevat eesmärki: kaitsta hoolekandeteenuseid kasutavaid inimesi kuritarvitamise või hooletusse jätmise eest, edendada füüsilist või vaimset tervist või ära hoida selle halvenemist, soodustada iseseisvust ja sotsiaalset kaasatust, parandada võimalusi ja väljavaateid elus, tugevdada perekondi ning kaitsta inimeste sotsiaalsete vajadustega seotud inimõigusi – autoriga kooskõlastatud toimetuse märkus.

inimesed kannaksid ise vastutust sotsiaalse toetamise ja hooldamise eest oma perekonnas ja kogukonnas.

Kriitika muutus eriti teravaks pärast nn *Baby P* juhtumit², kus 17 kuu vanune inglise poisslaps suri Londonis 2007. aastal pärast seda, kui ta oli saanud rohkem kui viiskümme vigastust kaheksa kuu jooksul. Selle aja vältel olid last regulaarselt külastanud kohalikud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad, kes aga ei võtnud midagi ette lapse abistamiseks. Juhtumi uurimiseks moodustatud valitsuse rakkerühm esitas programmi, mis nägi ette koolitusi, toetust ja supervisiooni praktikutele, juhtimise tõhustamist ja sotsiaaltöötajate suuremat sõltumatut otsustusõigust, avalikkuse suuremat teadlikkust, paremat uurimistulemuste rakendamist praktikasse ja spetsialistide ametikasvu süsteemi (*Social Work Task Force* 2009).

Ühendkuningriigi seaduste kohaselt on sotsiaaltöö kaitstud kutseala, mis tähendab seda, et mitte keegi ei saa ennast professionaalses kontekstis nimetada sotsiaaltöötajaks ilma selleta, et riiklik amet kannab ta vastavasse registrisse (Hussein 2011). 2016. aastal registreerisid nelja riigi vastavad ametid kokku 116 126 sotsiaaltöötajat.

Registreeritud sotsiaaltöötajad moodustavad väikese osa täiskasvanute hoolekandes töötajatest³, kus on ligikaudu 1,3 miljonit töökohta. Inglismaal töötab üle kahe kolmandiku nendest töötajatest erasektoris, ligi viiendik mittetulundussektoris ja 10% kohalikus omavalitsuses, kellest umbes 38%

töötab institutsionaalses hoolekandes (*Skills for Care* 2015). Lastehoolekande töötajaid ei ole lihtne eristada väikelastega töötavatest ja alushariduse töötajatest, kuid neid on rohkem kui täiskasvanutega töötavaid sotsiaaltöötajaid.

Laste mõeldud teenused ja laste turvalisuse kindlustamine

Alates 1970. aastatest on seoses laste surmaga lõppenud juhtumitega üles kerkinud tõsised küsimused selle kohta, kas spetsialistid edastasid teavet riskide ja laste kaitseks rakendatud meetmete kohta nõuetele vastavalt ning kas nad kogusid ja analüüsisid sotsiaalset informatsiooni asjakohaselt. Sellest ajendatuna on süsteem muutunud üha tsentraliseeritumaks ja bürokraatlikumaks, et tegevusi oleks võimalik juhtida haldusprotseduuride kaudu.

On tekkinud tunne, et riik püüab hoolekandeteenuste abil juhtida ja hallata vanemate käitumist ja avalikkuse suhtumist vanemlusse (Parton 1991). Munro väitis oma 2011. aastal avaldatud mõjukas ülevaates lastekaitse kohta aastatel 2010–2015 võimul olnud koalitsioonivalitsusele, et lastekaitse süsteem peaks keskenduma pigem laste vajadustele, mitte riskide hindamisele ja nende olemasolu kontrollimisele. Selleks tuleks väärtustada ja arendada sotsiaaltöötajate erialast pädevust, eelkõige nende lastega suhtlemise oskust.

Selle eesmärgi saavutamiseks püüdsid mõned kohalikud omavalitsused keskenduda töötajate ametikasvu toetamisele ja nende juhtimiskeskuste arendamisele. Üks mõjukas

² Sotsiaaltöös on *Baby P* juhtumist kirjutanud Mart-Peeter Erss numbris 6/2013, lk 55–57 – toim.

³ Inglismaal jaotub hoolekanne täiskasvanute- ning lastehoolekandeks. Esimene hõlmab toetust eakatele, väimse tervise probleemidega inimestele, õpiraskuste või füüsilise puudega inimestele, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamise probleemidega inimestele, kodututele, aga ka kuritarvitamise, hooletusse jätmise ning koduvägivalla ennetamist ning asjakohast toetust, mis on mõeldud perekondadele ja mitteformaalsetele hooldajatele. Lastehoolekanne ehk töö laste, noorte ja peredega hõlmab ennetavat tuge peredele ja lastekaitseteenuseid; laste asendushooldust; töötamist noorte õigusrikkujatega; töötamist laste ja noortega, kellel on õpiraskused või füüsiline puue, või kes on kodutud, ning perekondade ja mitteformaalsete hooldajate toetamist (Wikipedia, i. a) – autoriga kooskõlastatud toimetuse märkus.

näide sellest on Londonis Hackneys läbi viidud „sotsiaaltöö tagasivõitmise” projekt, milles keskenduti organisatsioonikultuuri muutmisele, toetamaks sotsiaaltöötajate iseseisvat professionaalset hindamisvõimet ja pakkumaks neile professionaalset juhtimist, tuge ja supervisiooni. Projekti hindamise tulemusena leiti, et paranes nii töö kvaliteet kui ka vähenesid kulud, kuna vähem lapsi sattus asendushooldusele, ning vähenes ka töötajate haigestumine ja stressitase (Cross, Hubbard ja Munro 2010). Hilisem uurimus kolme kohaliku omavalitsuse kohta näitas, et tõhusa ja iseseisva professionaalse praktika arendamisest ning toetamisest on rohkem kasu kui bürokraatlikest juhtumikorralduslikest lähenemistest (Forrester jt 2013).

Isikukeskne täiskasvanute hoolekanne

Täiskasvanute hoolekandes on toimunud kaks olulist sotsiaaltööga seotud suundumust: arendatakse teenuseid mitteformaalsetele hooldajatele ning üha enam järgitakse isikukesket lähenemist hoolduse planeerimisel ja juhtimisel. Mõlemad suunad kajastuvad Inglismaa 2014. aasta hoolekandeseaduses ja teiste ÜK riikide vastavates õigusaktides.

Alates 1990. aastatest on õigusaktidesse lisandunud nõue hinnata täiskasvanule mitteformaalset hooldust osutavate pereliikmete ja teiste mitteformaalsete hooldajate olukorda. See võimaldab pöörata tähelepanu sellele, et nii hooldajad kui ka nende täiskasvanud hooldatavad vajavad toetust eelkõige seoses juurdepääsuga haridusele ja vaba aja veetmise võimalustele. Mitteformaalsete hooldajate väärtusliku rolli tunnustamine on kiiduväärt, ehkki on kõlanud ka kriitikat selle kohta,

et nende toetamiseks ei eraldata piisavalt ressursse.

Hoolekandeteenuste valdkonnas alguse saanud isikukeskne hoolekanne on laienenud ka kogukonnas osutatavatele tervishoiuteenustele⁴. Siin järgitakse ülemaailmselt liikumist põhimõttel „sularaha hoolduse eest” (*cash for care*), mis on osa kodanike vaba valikut pooldavast poliitilisest tegevuskavast (Arksey ja Kemp 2008). Isikliku eelarve süsteemi⁵ puhul antakse täiskasvanutele sularaha, millega nad saavad maksta oma hoolduse eest kodus või hooldekodus või muude teenuste eest, selle asemel et sotsiaaltöötajad või muud spetsialistid otsustaksid ja korraldaksid vastavaid teenuseid. Sotsiaaltöötajad viivad läbi hindamise, seejärel koostatakse eelarve ja kliendid korraldavad ise oma hoolduse või palkavad isikliku abistaja kas ise või mõne kohaliku ühingu kaudu (SCIE 2016). Inimesed, kellel on füüsiline puue, õpiraskused või vaimse tervise probleemid ja kes tunnevad, et on võimelised ise või lähedaste toel oma hooldust korraldama, hindavad kõnealuse uuenduse abil saavutatud kontrolli ja valikuvõimalust. Samas on selgunud, et eakatel inimestel on raske sellist vastutust võtta. On tehtud kriitikat selle kohta, et sellise poliitika tagajärjel vähendab riik oma vastutust hooldusteenuste osutamise eest ega arvesta võimalike eriolukordadega.

Haridus ja koolitus

Pikka aega on päevakorral olnud küsimus, kas sotsiaaltöölalane haridus annab õppijatele piisava ettevalmistuse praktiliseks tööks. Osaliselt kajastab see võitlust hariduse kontrollimise üle: tööandjad tahavad, et ülikooli lõpetanud oleksid kohe valmis töötama kehtivate haldus- ja õigussüsteemide raames,

⁴ Kogukonnas osutatavad tervishoiuteenused (ingl *community health care provision*) on riiklikud tervishoiuteenused, mida osutakse tervisekeskustes või inimeste kodudes ja mis on vastupidiselt haiglates osutatavatele teenustele ennetuslikud – autor.

⁵ Vt lähemalt Zsolt Bugarszki artiklist Sotsiaaltöös 1/2016, lk 26–32 – toim.

seevastu õppeasutused soovivad keskenduda ulatuslikumale isikliku arengu ja akadeemilise ettevalmistuse protsessile.

Kahe hiljutise algatuse abil on püütud parandada erialase enesetäiendamise jätkamist pärast kõrghariduse omandamist.

Algatus „Hindamine ja tugi tööga alustamise aastal” on mõeldud kohalikes omavalitsustes nii laste kui ka täiskasvanutega tegelevatele sotsiaaltöötajatele ja see näeb ette, et esimesel tööaastal on sotsiaaltöötajal kindlaks määratud juhtumite arv ning ta saab täiendavat tuge ja koolitust. Algatus „*Professional capabilities framework*” (Professionaalse võimekuse raamistik) pakub rea valdkondi, milles sotsiaaltöötaja saab arendada oma ametialaseid oskusi vastavalt oma karjääri edenemisele (BASW 2016, *College of Social Work* 2015, vt ka *Social Work Reform Board* 2010).

Suurim valupunkt, mis on välja toodud Narey aruandes Inglismaa valitsusele (2015) lastega töötavate sotsiaaltöötajate ettevalmistamise kohta, seisneb selles, et traditsiooniline sotsiaaltööharidus keskendub üldistele erialastele ja teoreetilistele küsimustele, näiteks rühmisvastasele praktikale, selle asemel et valmistada sotsiaaltöötajaid ette konkreetseteks tööülesanneteks nagu näiteks lapse abivajaduse hindamine ja lapsega suhtlemine.

Tavapärase erialase kõrghariduse ja kraadiõppe kõrval pakutakse kahe katseprojekti lastega tegelevatele sotsiaaltöötajatele kiirkoolitusi. Esimene neist, kiirendatud korras pakutav magistriõppe kursus „*Step up to social work*” (Samm edasi sotsiaaltöös) on suunatud kõrgelt kvalifitseeritud osalejatele. Programm viiakse läbi kohalike tööandjate

juhitud piirkondlike konsortsiumide kaudu ning see hõlmab ka kohalikke ülikoole. Hindamine näitas, et tööandjad ja tudengid pidasid programmi edukaks ja väärtuslikuks. Kursuse läbinud kõrgkooli vilistlased jätkasid lastekaitsealast tööd ja nende karjäär arenes tõusvas joones. (Smith jt 2013, Hackett jt 2016). Samas on väljendatud kahtlust, et kas lastega töötamisele keskendumise puhul on võimalik omandada piisaval tasemel teadmisi ja oskusi üldiseks sotsiaaltööks (*generic social work*).

Teine katseprojekt, „*Frontline*” (Eesliin) on 16 kuud vältav kursus lastega töötavatele sotsiaaltöötajatele, milles praktilal on suur osa. Projekti valitud edukad kõrgkooli lõpetanud töötavad asutustes kogenud vanemsotsiaaltöötaja käe all, kes toetab nende haridusalast ja praktilist arengut. Väljaspool töökohta korraldatavatel seminaridel pakutakse piiratud mahuga õppekava, milles omandatut rakendatakse töökohas. Siin keskendutakse otseselt praktiliste oskuste omandamisele süsteemse teoreetilise mudeli raames ja kahe sekkumisteooria õpetamise abil, milleks on motiveeriv intervjuerimine ja sotsiaalse õppimise teoorial põhinev vanemlusprogramm. Selle projekti varaste etappide hindamist käsitlev uurimus (Maxwell jt 2016) näitab, et tööandjad ja tudengid on nimetatud projekti hästi vastu võtnud. Kuid sel viisil korraldatud õpe on siiski vastuoluline oma lühiduse (kraadiõppe kursus kestab tavaliselt ligemale kaks aastat) ja piiratud mahuga õppekava tõttu, mis tähendab, et osalejatele ei tutvustata kõiki sotsiaaltöö ideid ja väärtusi, mistõttu nende suutlikkus kasutada muid sekkumismudeleid võib jääda piiratuks. S

Viidatud allikad

Arksey, H., Kemp, P. A. (2008). Dimensions of Choice: A narrative review of cash-for-care schemes. York: University of York Social Policy Research Unit. www.york.ac.uk/inst/spru/research/pdf/CashReview.pdf (12.10.16).

- BASW** (2016). Professional Capabilities Framework. www.basw.co.uk/pcf/ (12.10.16).
- College of Social Work** (2015). Review of the Professional Capabilities Framework (PCF): Final Report. www.basw.co.uk/pcf/pcfreview2015.pdf. (12.10.16).
- Cross, S., Hubbard, S., Munro, E.** (2010). Reclaiming Social Work: London Borough of Hackney Children and Young People's Services. London: Human Reliability/London School of Economics and Political Science. www.safeguardingchildren.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Eileen-Munro-Review-of-the-Hackney-Model.pdf (12.10.16).
- Forrester, D., Westlake, D., McCann, M., Thurnham, A., Shefer, G., Glynn, G., Killian, M.** (2013). Reclaiming Social Work? An Evaluation of Systemic Units as an Approach to Delivering Children's Services. Luton: University of Bedfordshire, Tilda Goldberg Centre. http://cdn.basw.co.uk/upload/basw_11812-8.pdf (12.10.16).
- Hackett, S., Smith, R., Stepanova, E., Venn, L., Carpenter, J., Patsios, D.** (2016). Initial Findings: Step Up to Social Work Longitudinal Evaluation. Durham: University of Durham. www.dur.ac.uk/resources/sass/research/SUSWInitialfindings21Mar2016.pdf (12.10.16).
- Hussein, S.** (2011). Social Work Qualifications and Regulation in European Economic Area (EEA). London: General Social Care Council. www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/scwru/pubs/2011/hussein2011eea.pdf (12.10.16).
- Maxwell, N., Scourfield, J., Le Zhang, M., de Villiers, T., Hadfield, M., Kinnersley, P., Metcalf, L., Pithouse, A., Tayyaba, S.** (2016) Independent evaluation of the Frontline pilot: Research report. London: Department for Education. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554116/RR507_Frontline_pilot_evaluation.pdf (12.10.16).
- Munro, E.** (2011). The Munro Review of Child Protection, Final Report: A child-centred system. London: TSO. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175391/Munro-Review.pdf (12.10.16).
- Narey, M.** (2015). Making the education of social workers consistently effective: Report of Sir Martin Narey's independent review of the education of children's social workers. London: Department of Education. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287756/Making_the_education_of_social_workers_consistently_effective.pdf (12.10.16).
- Parton, N.** (1991). Governing the Family: Child care, child protection and the state. London: Macmillan.
- SCIE** (2016). Person-centred care, personalisation resources and services. London: Social Care Institute for Excellence. www.scie.org.uk/atoz/?f_az_subject_thesaurus_terms_s=person-centred+care&f_az_subject_thesaurus_terms_s=personalisation&st=atoz&page=1 (12.10.16).
- Smith, R., McLenachan, J., Venn, L., Weich, H., Anthony, D.** (2013). Step up to Social Work Programme Evaluation 2012, The Regional Partnerships and Employers Perspectives: Research Report. London: Department for Education. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205617/DFE-RR290.pdf (12.10.16).
- Skills for Care** (2015) The state of the adult social care sector and workforce in England. London: Skills for Care. www.skillsforcare.org.uk/NMDS-SC-intelligence/NMDS-SC/Workforce-data-and-publications/Workforce-data-and-publications.aspx (12.10.16).
- Social Work Reform Board** (2010). Building a safe and confident future: One year on Overarching professional standards for social workers in England. London: Department for Education. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/180792/DFE-00602-2010-2.pdf (12.10.16).
- Social Work Task Force** (2009). Building a safe, confident future: The final report of the Social Work Task Force. London: Department for Children, Schools and Families. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/01114-2009DOM-EN.pdf> (12.10.16).